



La péritonite fongique : Une complication rare mais redoutable en dialyse péritonéale (A propos de 3cas)

A. BEGRICHE (asma_hanene@live.fr)
S.TALBI, L.KRIBECHE, I.BENHARKAT, Z.MAIZA, H.KHELOUFI
Service de Néphrologie et Hémodialyse –CHU de Sétif-

Introduction :

La dialyse péritonéale(DP) est une alternative thérapeutique à l'hémodialyse et à la transplantation rénale pour les patients en insuffisance rénale chronique terminale(IRCT).C'est une technique d'épuration à domicile permettant une meilleure tolérance cardiovasculaire et préservant la fonction rénale résiduelle. Cependant, elle est gravée de complications dont les plus fréquentes sont les complications infectieuses ;dominées par les infections bactériennes gram positif (staphylococcus épidermidis, staphylococcus aureus) et secondairement par des bactéries Gram négatif. la péritonite fongique est une infection rare mais grave pouvant mettre en jeu le pronostic fonctionnel du péritoine et vital du patient .

Matériel et méthode

Notre expérience rapporte trois cas de péritonite fongique observés au cours d'une seule année 2025-2026 au sein du service de néphrologie ;chez des patients sous dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA). Il s'agit d'un enfant âgé de 04 ans en insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) depuis un an suite au syndrome de Galloway (une anomalie génétique associant un syndrome néphrotique et une atteinte du système nerveux central).les deux autres femmes âgées respectivement de 35ans et 60 ans en IRCT sur néphropathie indéterminée pour la première et néphropathie lupique pour la deuxième,. Nous décrivons les aspects clinique, biologique, microbiologique et radiologique des patients ainsi qu'aux suites thérapeutiques et évolutives de ces derniers.

Résultats:

Les signes cliniques prédominants étaient la turbidité du dialysat et les douleurs abdominales atroces pour les trois patients.

L'enfant : Mis sous DP depuis 1 an, on note dans les antécédents une péritonite bactérienne à staphylocoque (SARM) justifiant une antibiothérapie intensifiée à base de vancomycine. L'examen direct du liquide de dialyse péritonéale objectivait plus de 1000 éléments blanc à prédominance polynucléaires (PNN) 98% avec des levures isolées. la culture a identifié candida albicans et Saccharomyces cerevisiae était également identifiée à l'examen de l'orifice de sortie du cathéter. L'échographie abdomino-pelvienne a montré des cloisons au niveau du péritoine. L'évolution était marquée par l'installation d'une fongémie avec une pneumopathie et une détresse respiratoire justifiant un séjour en réanimation.

La première patiente : Mise sous DP depuis 4ans, son histoire est marquée par plusieurs épisodes de péritonite bactérienne avec une péritonite tuberculeuses ayant reçu un traitement antituberculeux. L'examen direct du liquide de dialyse péritonéale objectivait plus de 1000 éléments fait de 27% de PNN, 73% de lymphocytes. la culture du liquide a mis en évidence Candida sp. Son échographie a également objectivé une péritonite cloisonnée

La deuxième patiente : Mise sous DP depuis 2 ans, la particularité de cette patiente c'est qu' elle a présenté une péritonite fongique primitive autrement dit c'est le premier épisode de péritonite infectieuse

DATE DU PRELEVEMENT : 24/02/26 N° : 191
TYPE DU PRELEVEMENT : LDP
SERVICE : Nph
EXAMEN DIRECT
- ASPECT DU LIQUIDE : liquide trouble
- CYTOLOGIE : 1000 éléments blancs / mm³
98 % DE POLYNUCLEAIRES altérés et intacts
02 % DE LYMPHOCYTES
Présence / Absence de germes à l'examen direct :
MICRO - ORGANISME ISOLE : Levures

L'examen direct et culture du liquide péritonéal de l'enfant

Examen demandé : P/ liquide de dialyse péritonéale
RESULTAT
Examen direct : négatif
Leucocytes +++
Culture : présence de levures
Identification : Candida albicans
Sétif le : 19/02/2026

Service : Nph Numéro : 01
RESULTAT
Présence d'antigène mannane dans le sérum
Sétif le : 23/03/2026

Sérologie candidosique témoignant d'une candidémie

Examen demandé : P/ Orifice du cathéter du dialyse péritonéale
RESULTAT
Examen direct : négatif
Culture : présence de levures
Identification : Saccharomyces cerevisiae
Sétif le : 19/02/2026

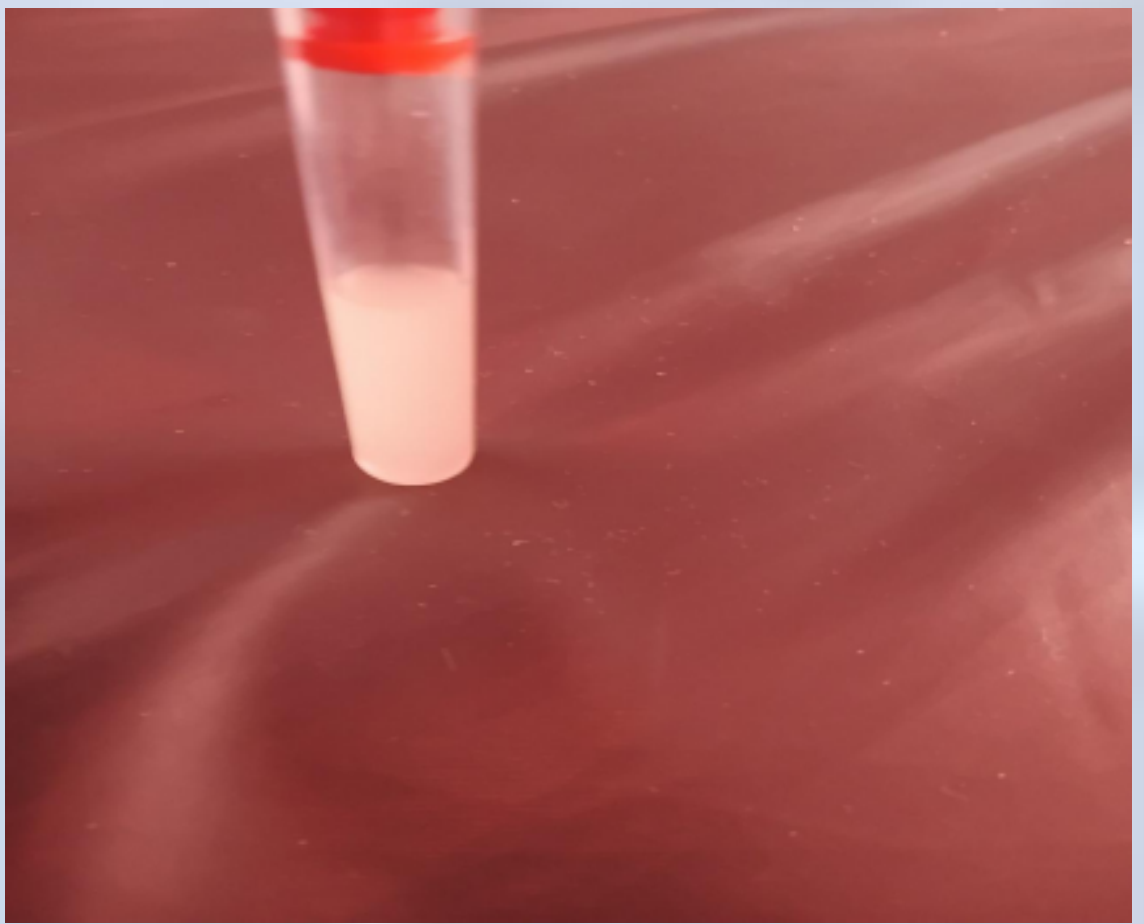
Identification de la levure prélevée à l'orifice de sortie du cathéter de DP

DATE DU PRELEVEMENT : 20.11.25 N° : 332
TYPE DU PRELEVEMENT : DP
SERVICE : Nph
EXAMEN DIRECT
- ASPECT DU LIQUIDE : clair
- CYTOLOGIE : 1000 éléments blancs / mm³
27 % DE POLYNUCLEAIRES altérés et intacts
73 % DE LYMPHOCYTES
Présence / Absence de germes à l'examen direct :
MICRO - ORGANISME ISOLE : levures (voir au labo de microbiologie)

L'examen direct et culture du liquide péritonéal de la 2ème patiente

Service : Nph Numéro : 340
Examen demandé : P/ liquide de dialyse
RESULTAT
Examen direct : négatif
Culture : Candida sp
Sétif le : 02/12/2025

Un antifongique à base de caspofungine a été instauré. L'ablation du cathéter de DP a été faite chez les trois patients dans un délai d'une semaine avec transfert définitif en hémodialyse



Liquide péritonéal d'aspect trouble

Conclusion:

La péritonite fongique est une complication infectieuse redoutable chez les patients en dialyse péritonéale. Les antécédents de péritonites bactériennes répétées, l'antibiothérapie prolongée, l'immunodépression et une mauvaise hygiène constituent les principaux facteurs de risque. (ISPD) International Society for Peritoneal Dialysis recommande une prophylaxie antifongique au cours des péritonites infectieuses afin de réduire le risque de péritonite fongique. Le diagnostic précoce et l'administration de traitement par des agents antifongiques, tel que le caspofungine peut réduire le taux de mortalité. La collaboration entre le clinicien et le biologiste permet une prise en charge plus efficace et améliore le pronostic.